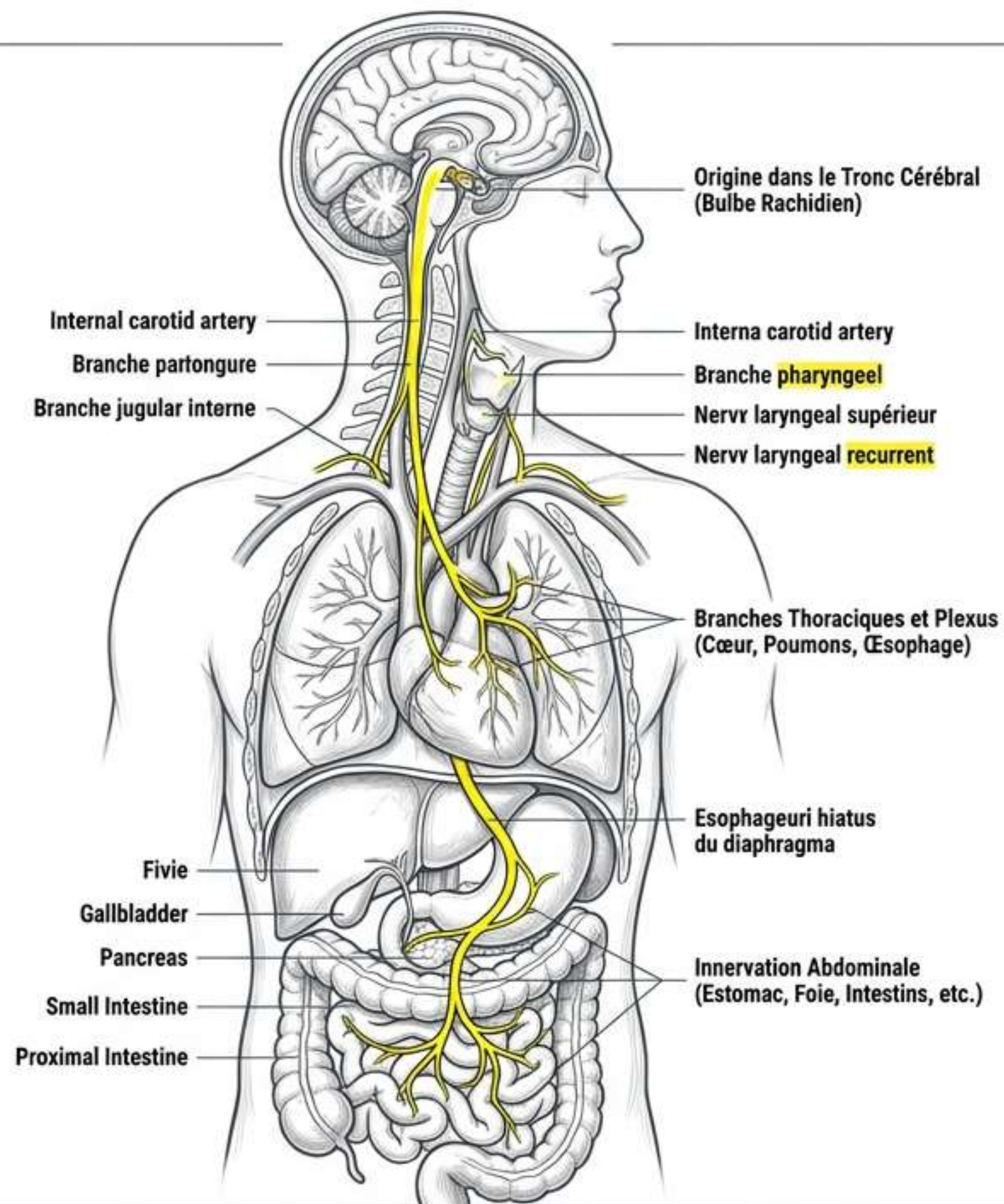


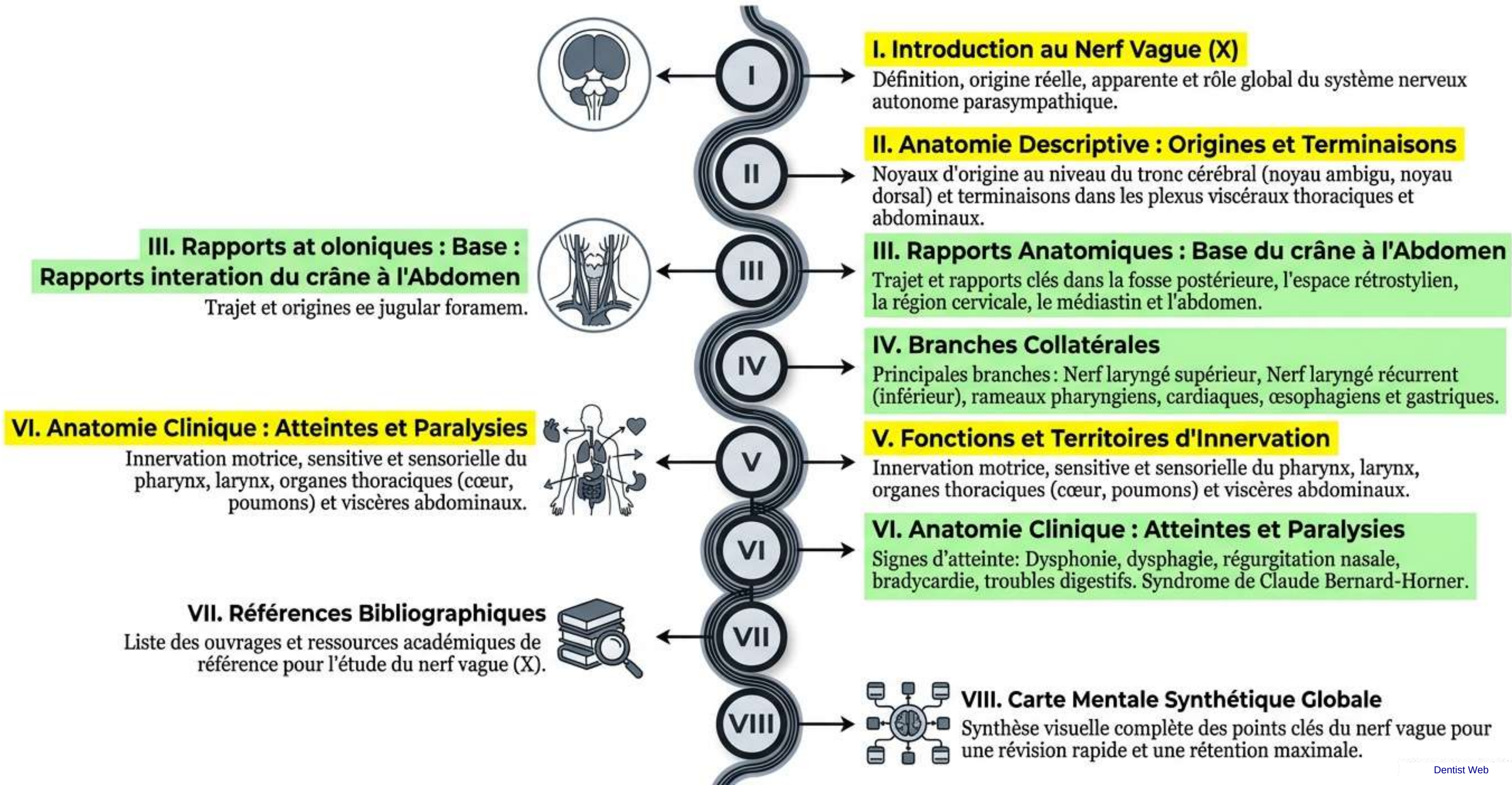
Le Nerf Vague (X)

Guide d'Étude Anatomique Complet & Atlas Clinique

Synthèse intégrale à haut rendement — Origines, Trajets, Fonctions et Corrélations Diagnostiques.



LE NERF VAGUE (X): ITINÉRAIRE ET ANATOMIE CLINIQUE

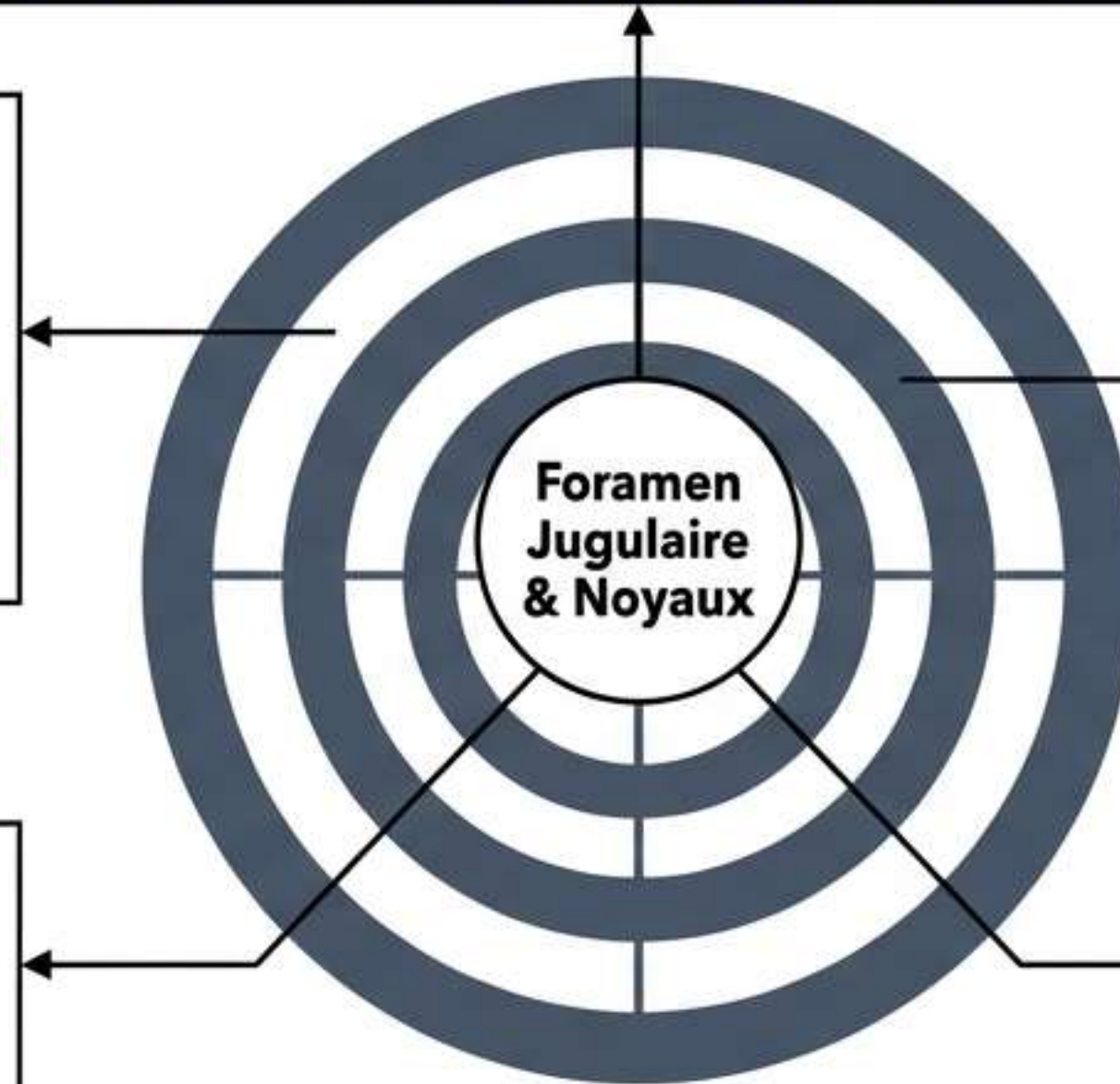


ANALYSE DES MODÈLES D'EXAMEN : NERF VAGUE (X)

Sujets les plus répétés (Cibles principales) : La nature mixte des contingents (3 noyaux d'origine), les noms spécifiques des ganglions (Jugulaire vs Plexiforme), et le passage par le foramen jugulaire.

Pièges potentiels (Traps) :
Confondre l'origine du contingent végétatif (Noyau dorsal) avec le moteur (Noyau ambigu).
Inversion des rapports antérieurs/postérieurs entre le X droit et le X gauche au niveau de l'œsophage.

Nombres fréquemment testés :
Xème nerf crânien, 3 contingents, 2 ganglions, 6 étapes de trajet intra et extra-crânien.



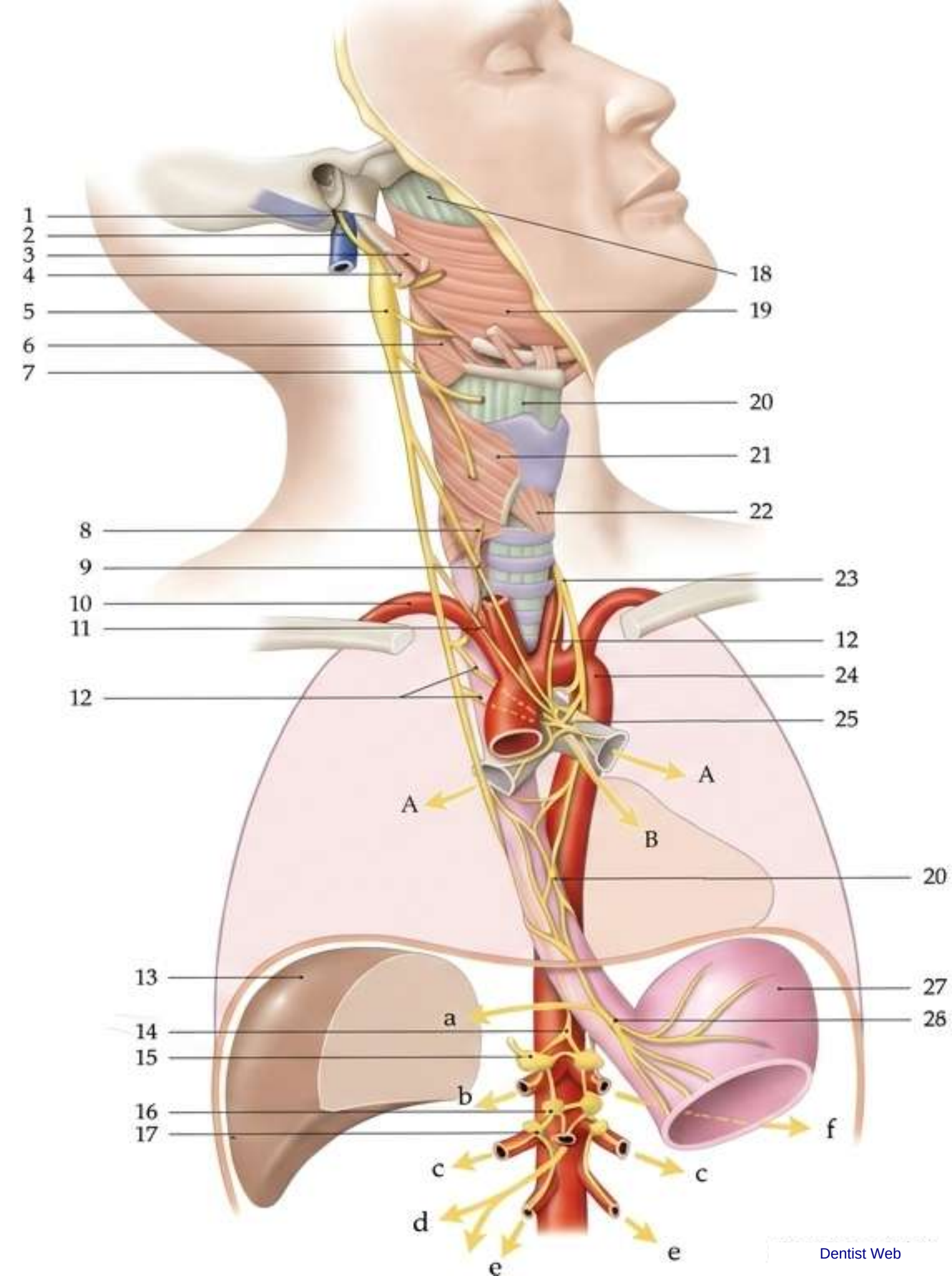
Zones rarement examinées : Les branches collatérales cervicales mineures (ex: nerf du sinus carotidien).

Indice de confiance de prédiction :
92% (Basé sur les asymétries topographiques classiques et les signes cliniques pathognomoniques).

Légende Visuelle Strict : Surlignage Jaune = Contenu exact d'examen passé. Surlignage Vert = Prédiction à haut risque.

I - Introduction au Nerf Vague (X)

- **Définition** : Le nerf vague ou pneumogastrique est le Xème nerf crânien.
- **Nature** : C'est un nerf mixte (sensitivomoteur), somatique et viscéral.
- **Étendue du territoire** : Le territoire s'étend de la tête à l'abdomen.
- **Composante Végétative** : Il est riche en fibres parasympathiques. (Appartient en grande partie au système végétatif [Predicted - Fundamental concept for dysautonomia integration]).



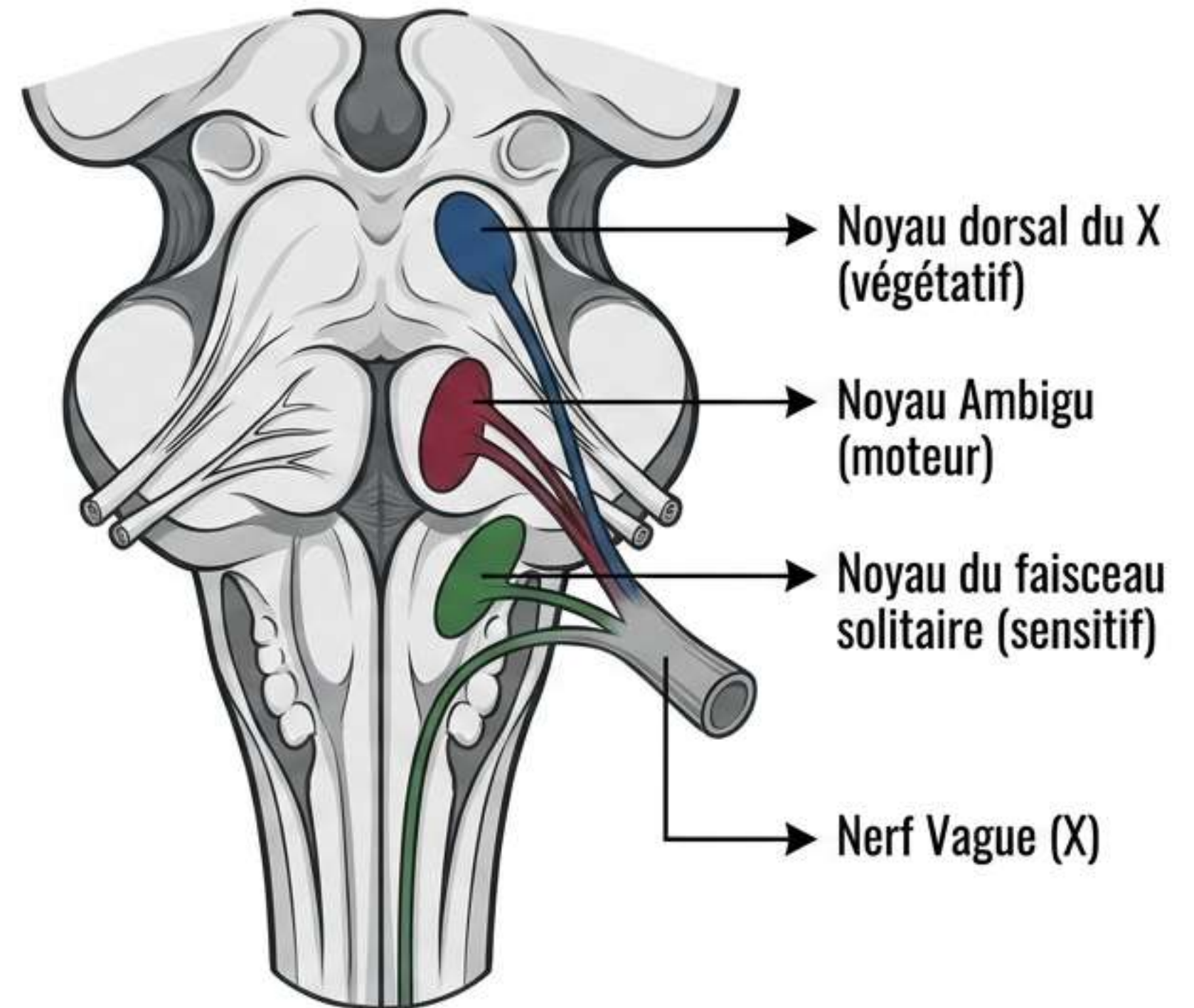
II - Anatomie Descriptive : Origine et Noyaux

A - Origine (Noyaux du tronc cérébral) :

Il présente trois contingents provenant du noyau ambigu, noyau dorsal et le faisceau solitaire. [Ref: Q14 (2024 2°EMD)]

Ventilation fonctionnelle :

- 1 - Noyau dorsal du X (contingent végétatif).
- 2 - Noyau Ambigu (contingent moteur).
- 3 - Noyau du faisceau solitaire (contingent sensitif).



II - Anatomie Descriptive : Le Trajet Global

B - Trajet (Les 6 Étapes Successives) :



Étape 1 : Fosse crânienne postérieure (Trajet Intra-crânien).



Étape 2 : Trou déchiré postérieur (Foramen jugulaire).



Étape 3 : Espace latéro-pharyngien.



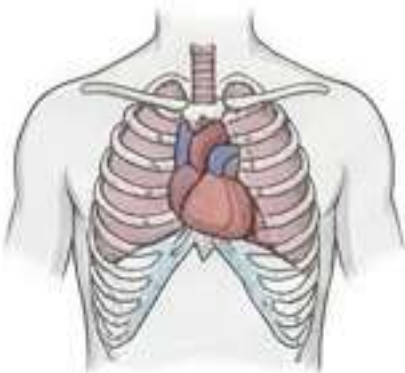
Étape 4 : Orifice supérieur du thorax.



Étape 5 : Thorax.



Étape 6 : Hiatus œsophagien du diaphragme.



III - Rapports Anatomiques : Base du Crâne et Foramen Jugulaire

1 - Dans l'étage postérieur de la base du crâne :

Le nerf se dirige latéralement et horizontalement vers le foramen jugulaire.

2 - Dans le foramen jugulaire (Trou déchiré postérieur) :

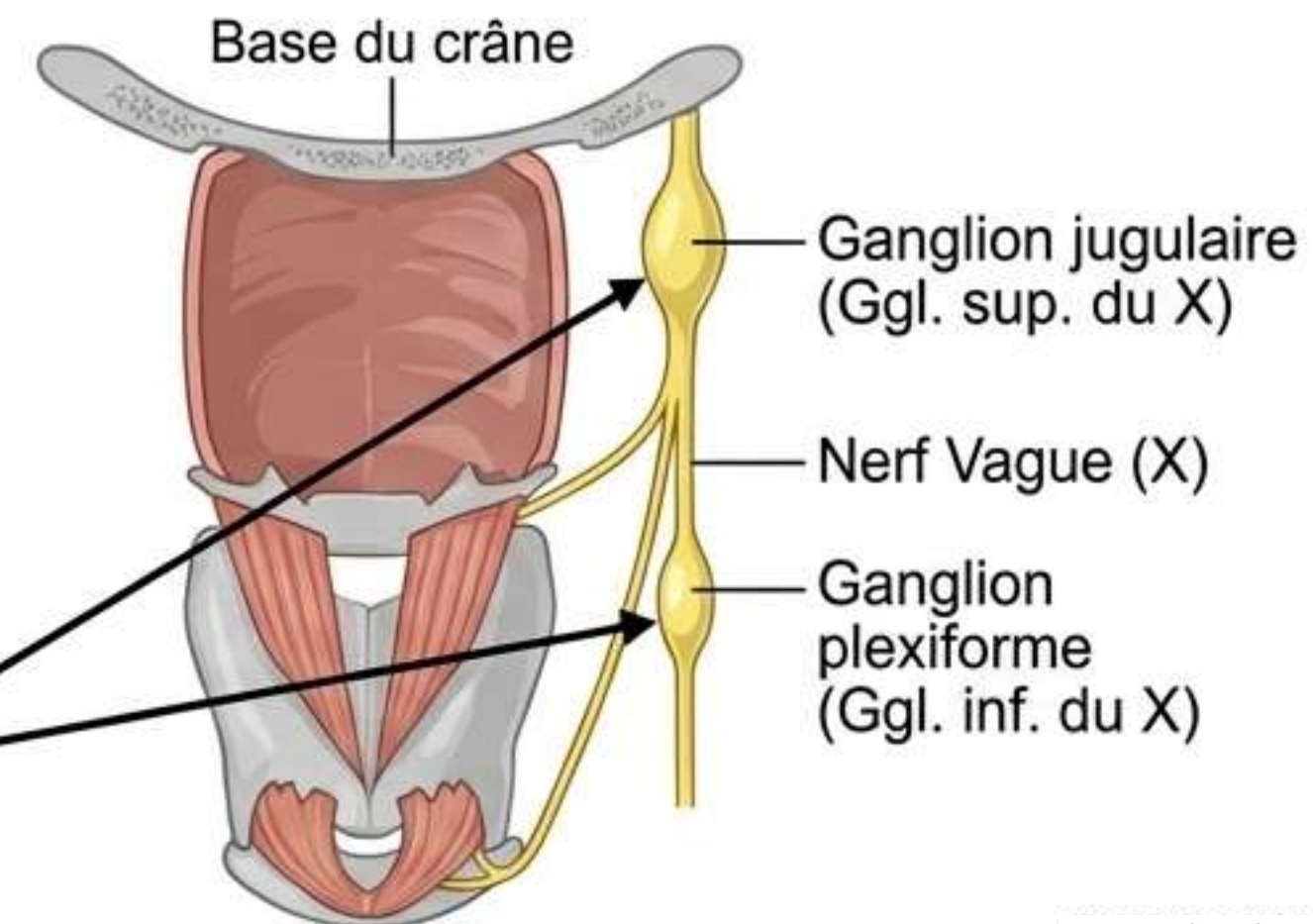
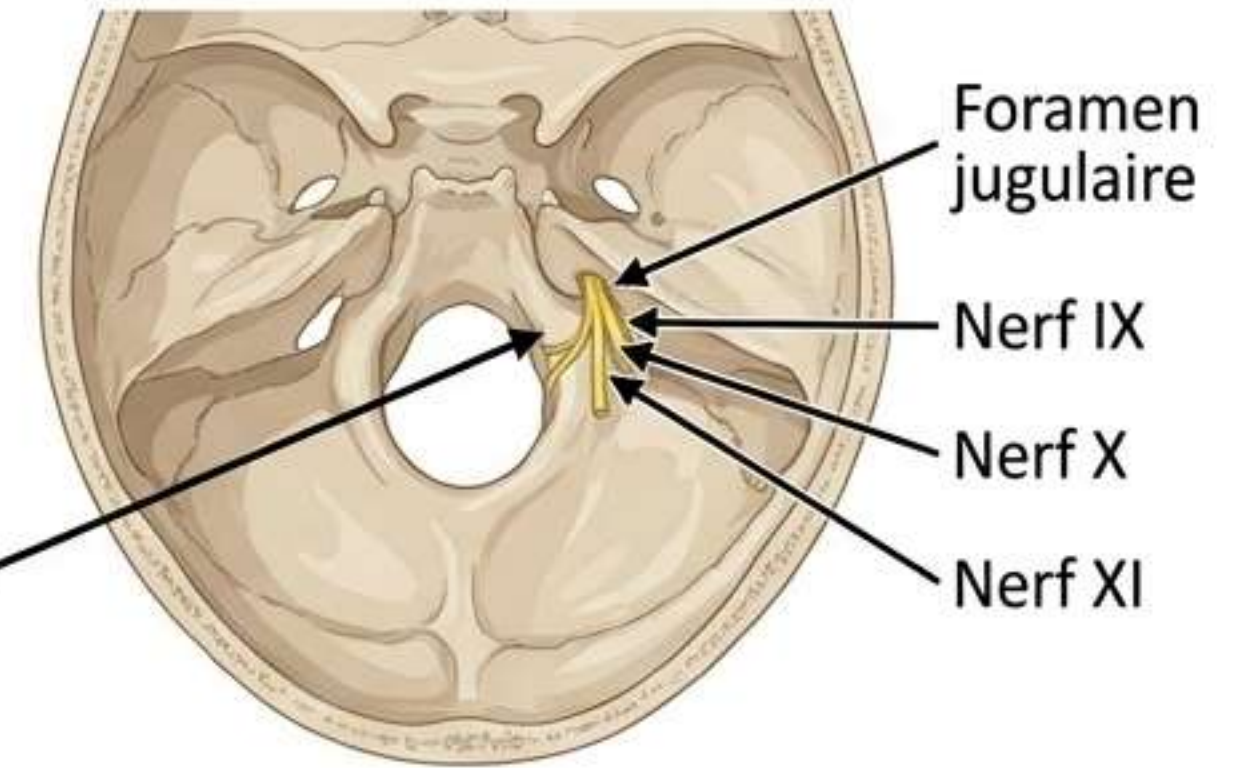
Sort de la base du crâne par le foramen jugulaire. [Ref: Q14 (2024 2°EMD)]

Il est accompagné des nerfs IX et XI et de l'artère méningée postérieure.

Il présente le ganglion supérieur du vague (ganglion jugulaire).

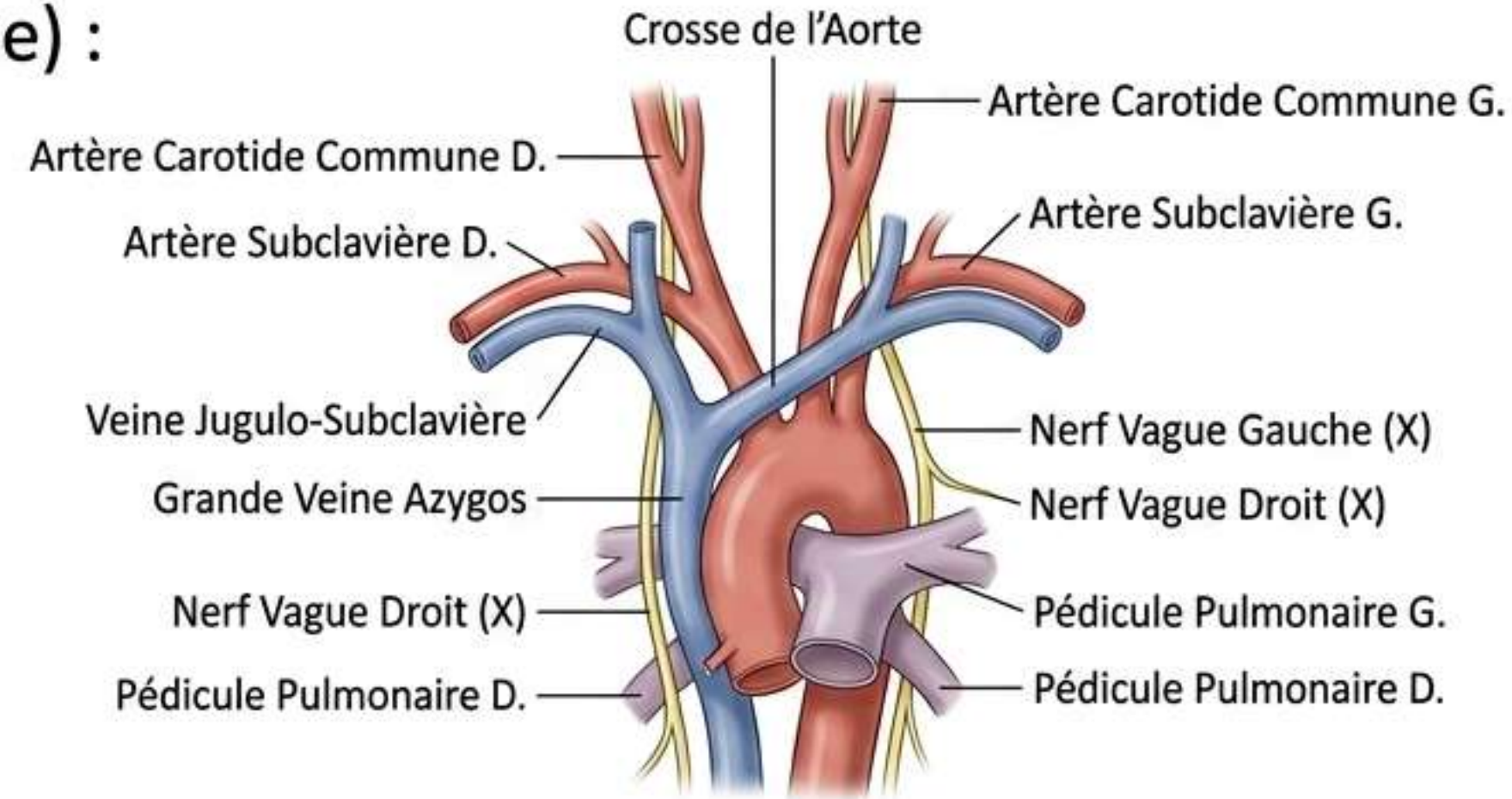
3 - À la sortie du foramen jugulaire (Espace latéro-pharyngien) :

Son ganglion inférieur est appelé ganglion plexiforme (le supérieur est le ganglion jugulaire). [Ref: Q14 (2024 2°EMD)]



III - Rapports Anatomiques : Région Cervico-Thoracique

4 – Asymétrie Topographique (Cervico-Thoracique) :



Nerf Vague Gauche (X Gauche) :

- Chemine le long de la face externe de l'artère carotide commune.
- Chemine sur la face antéro-externe de la crosse de l'aorte.
- Passe derrière le pédicule pulmonaire gauche.
- Dans le médiastin postérieur : passe en avant de l'œsophage. [Predicted - Classic orientation trap]

Nerf Vague Droit (X Droit) :

- Chemine entre l'artère subclavière et le confluent veineux jugulo-subclavier.
- Descend en dedans de la crosse de la grande veine azygos.
- (Pédicule pulmonaire droit implicite, plexus pulmonaire commun).
- Dans le médiastin postérieur : passe en arrière de l'œsophage. [Predicted - Classic orientation trap]

Plexus Communs : Derrière les pédicules pulmonaires, les 02 nerfs donnent le plexus pulmonaire. Dans le médiastin postérieur, le X donne les plexus œsophagiens.

III & II - Rapports et Terminaisons : Abdomen

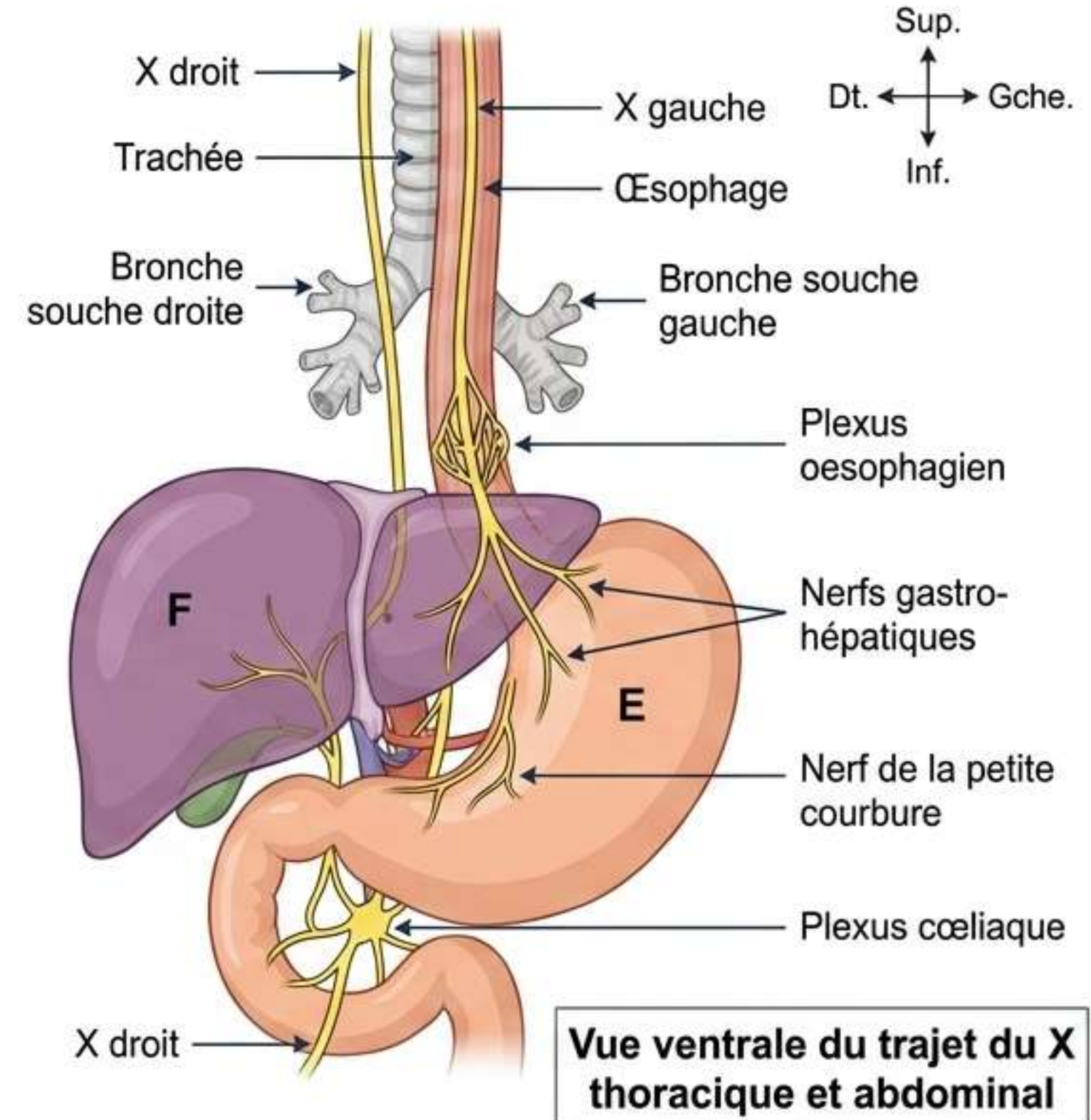
5 - Dans le hiatus œsophagien :

- Le **X gauche** est sur la face ventrale de l'œsophage.
- Le **X droit** est sur la face dorsale de l'œsophage.

6 - Dans la cavité abdominale (Terminaisons) :

- **X Gauche** : Reste sur la face ventrale de l'œsophage. Se divise en rameaux terminaux : gastriques et hépatiques.
- **X Droit** : Descend en arrière de l'œsophage. Se termine dans le plexus coeliaque (solaire).

Extensions : Le nerf vague fournit plusieurs ramifications qui vont aux plexus mésentériques supérieur et inférieur.



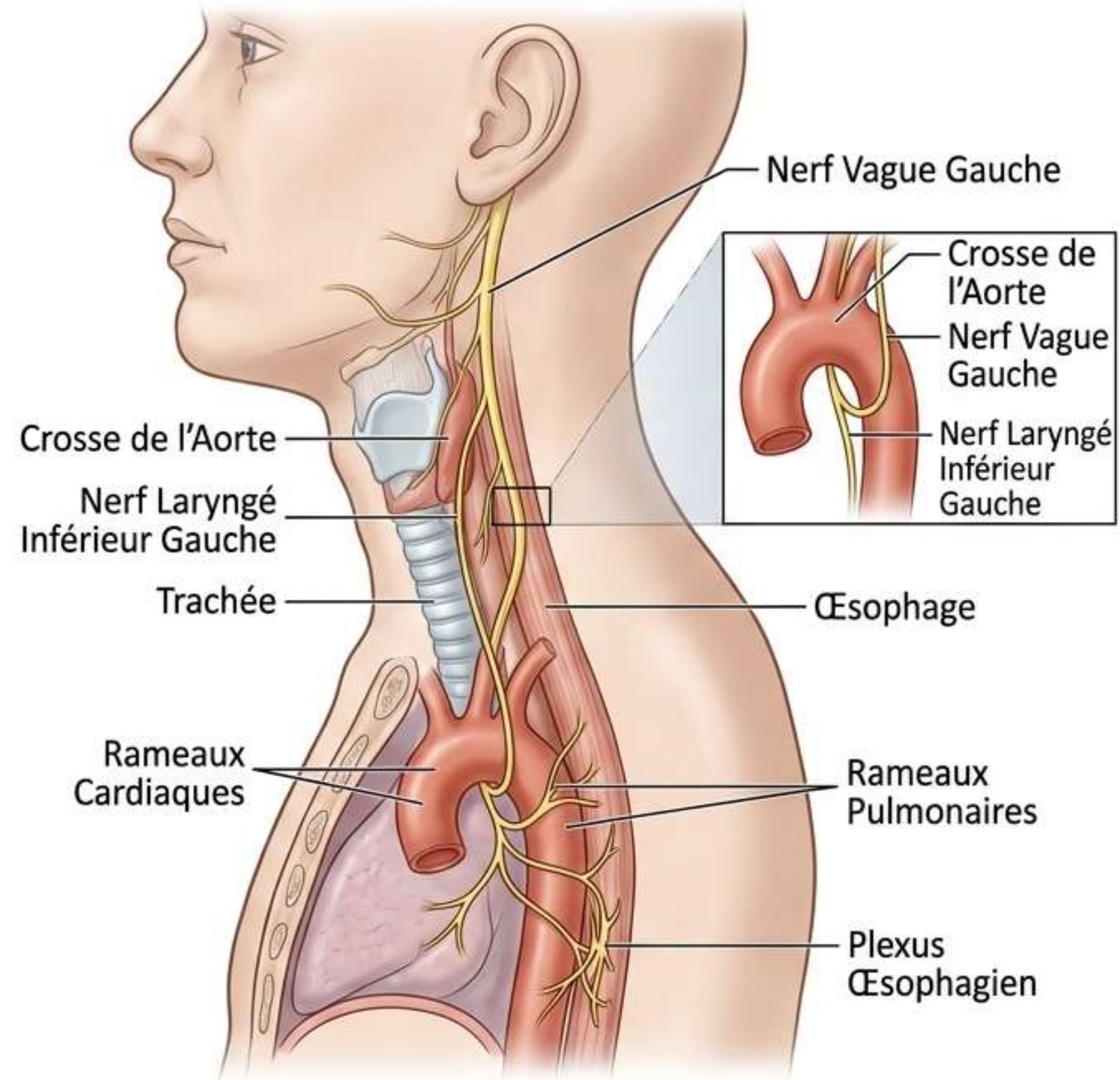
IV - Branches Collatérales (Cervicales et Thoraciques)

A - Collatérales cervicales :

- Il donne des rameaux **méningé** et **auriculaire** dès la base du crâne. [Ref: Q14 (2024 2°EMD)]
- Des rameaux : **méningé**, **auriculaire**, **pharyngiens**.
- Le **nerf du sinus carotidien**.

B - Collatérales thoraciques :

- **Le nerf laryngé inférieur (récurrent) gauche** : Naît à gauche de la **crosse de l'aorte**, il la contourne et monte dans l'**angle dièdre trachéo-œsophagien**. (Trajet asymétrique à haut rendement clinique. [Predicted])
- Les rameaux cardiaques thoraciques.
- Les rameaux **pulmonaires**.
- Les **rameaux œsophagiens**.



VI - Fonctions et Territoires : Motricité et Sensibilité

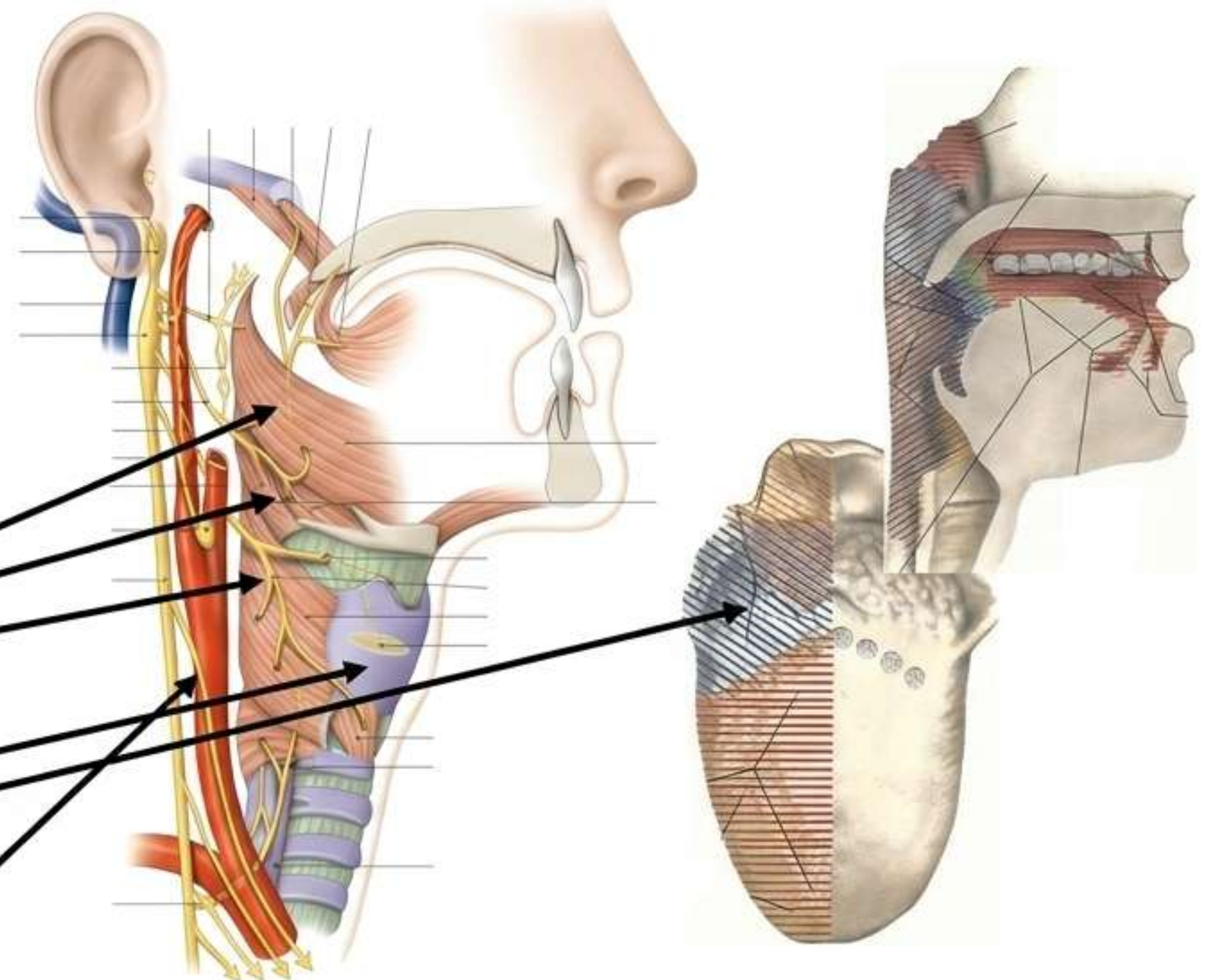
Le nerf X assure 03 fonctions principales :

01 - Une fonction motrice :

- Innerve les muscles du pharynx et du voile du palais : Rôle dans la **Déglutition** (temps pharyngien).
- Innerve les muscles du larynx : Rôle dans la **Phonation**.

02 - Une fonction sensitive : Véhicule la sensibilité de :

- Muqueuse du **pharynx** et du larynx.
- **Épiglotte**.
- **Langue** (Spécifiquement la zone située derrière le V lingual [Predicted - Classic sensory mapping trap]).
- **Zone** cutanée rétro-auriculaire et conduit auditif externe.

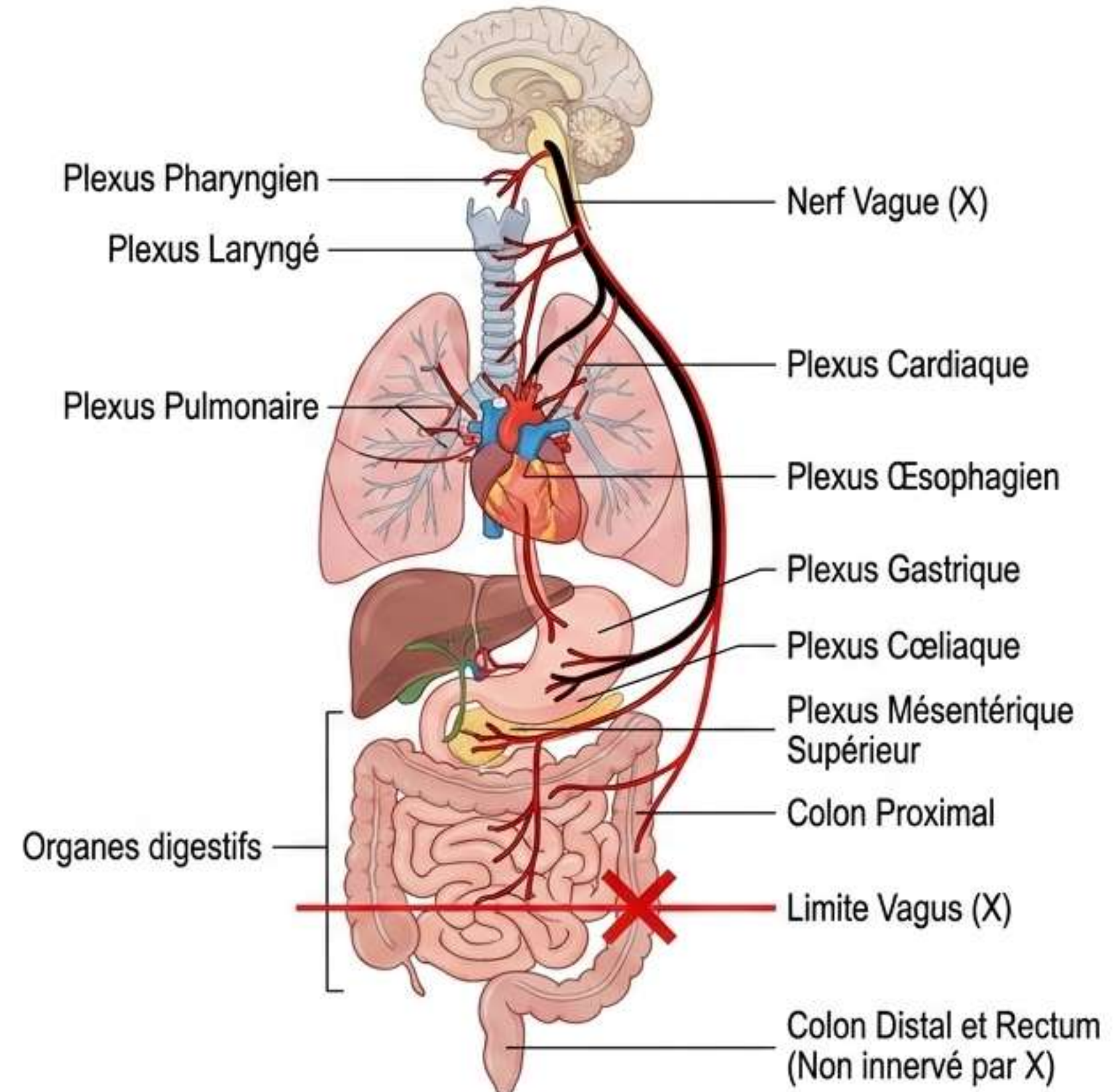


VI - Fonctions et Territoires : Système Végétatif

03 - Une fonction végétative :

Contrôle la motricité et la sensibilité des viscères thoraciques et abdominaux :

- Organes respiratoires.
- Cœur et Gros vaisseaux.
- Organes digestifs (Exception stricte : Ne contrôle ni le colon gauche, ni le rectum. [Predicted - Anatomical boundary trap]).



VII - Anatomie Clinique : Atteintes et Paralysies

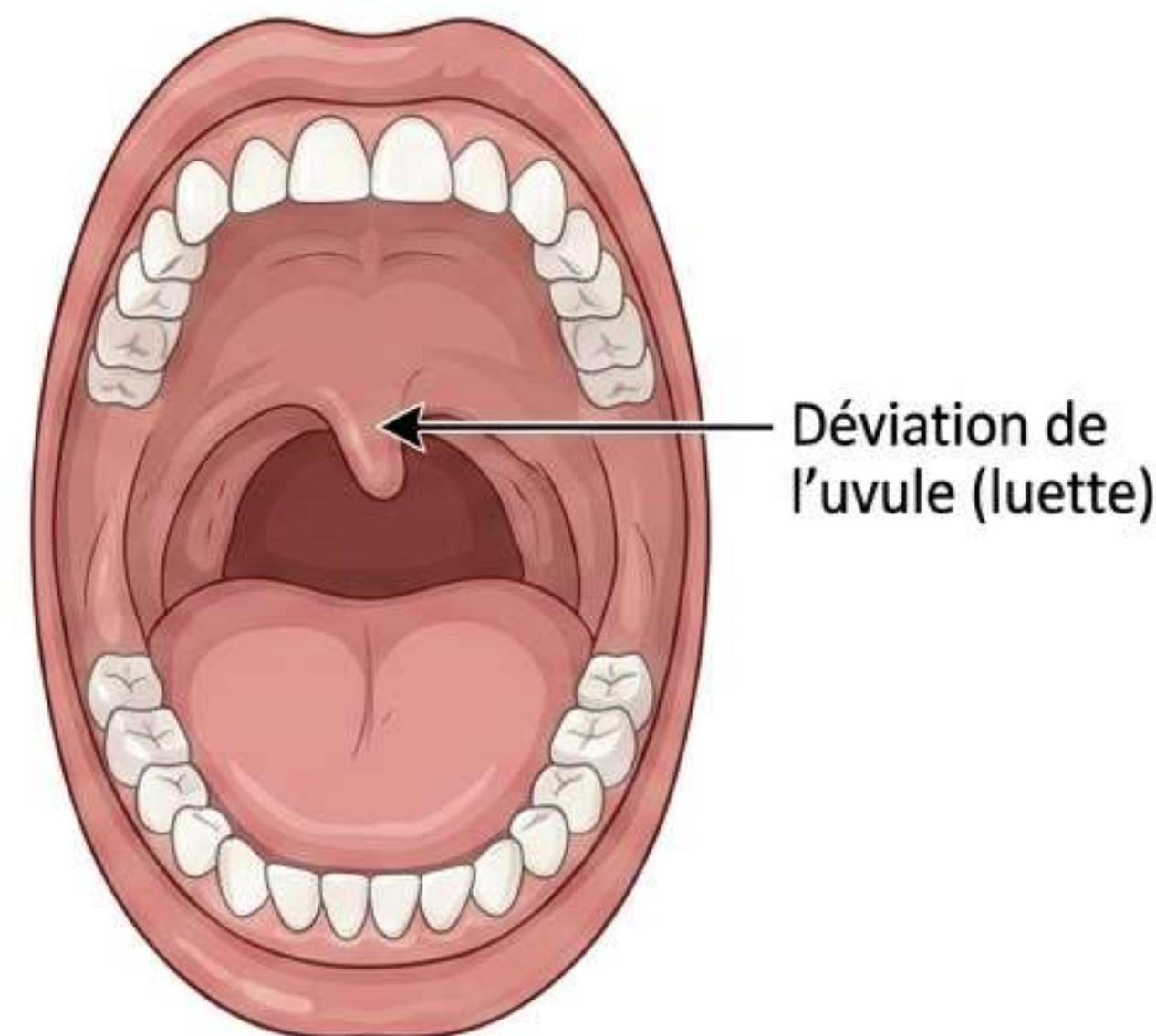
1 - Atteinte du nerf vague :

Paralysie Bilatérale (Atteinte Sévère) :

- **Dysphagie** : Trouble majeur de la déglutition.
- **Dysphonie** : Voix étouffée ou rauque (atteinte laryngée bilatérale).

Paralysie Unilatérale :

- **Signe du rideau** : Déviation de l'uvule (luette) du côté sain. [Predicted - Pathognommic visual sign]
- **Modification vocale** : Voix aigüe.



Références Bibliographiques du Cours

Sources Pédagogiques Officielles (Dr RETIA.F) :

1. Anatomie topographique SNC « BOUCHET »
2. Atlas d'anatomie « NETTER »
3. Anatomie clinique « PIERRE KAMINA »
4. Neuroanatomie clinique « André GOUAZÉ »
5. Anatomie humaine tome IV « H.ROUVIERE »
6. Le système nerveux central « G.LAZORTHES »

